PODCAST · EPISÓDIO COM DR. CESAR · CARDIOLOGIA

# Cuidar do coração antes que ele peça socorro.

Roteiro completo do episódio: perguntas do host, direcionamento das respostas, frases para cortes e plano de distribuição. **Prevenção, obesidade e longevidade** para quem tem 50+ em Santo André e no ABC Paulista.

**18 anos**
de medicina, 16 deles na cardiologia

**10 blocos**
mais bate-bola, sinais de alerta e pílulas do público

**~60 min**
de conversa, rendendo cerca de 30 cortes

**50+**
público prioritário, com fatores de risco

BRIEFING DO EPISÓDIO

# Um episódio para quem acha que ainda não é hora de ir ao cardiologista.

**Objetivo:** posicionar o Dr. Cesar como referência em cardiologia e prevenção cardiovascular em Santo André e no ABC Paulista, mostrando experiência, propósito e a importância do acompanhamento contínuo.

### PÚBLICO PRIORITÁRIO

Pessoas acima dos 50 anos, principalmente com comorbidades ou fatores de risco, que querem envelhecer com saúde, autonomia e qualidade de vida.

### PÚBLICO QUE COMPARTILHA · NOVO

Filhos de 25 a 45 anos que cuidam dos pais, e quem treina pesado achando que está protegido. Eles levam o episódio para dentro de casa.

**MENSAGEM CENTRAL**

**Não precisamos esperar um infarto, um AVC ou qualquer outro problema para começar a cuidar do coração.**

### O QUE O OUVINTE PRECISA LEVAR

01 **Obesidade é saúde, não só estética**
Uma condição que compromete o coração e outros sistemas.

02 **50+ com comorbidades é prioridade**
Obesidade com pressão alta, diabetes ou colesterol pede avaliação já.

03 **Tirzepatida é tratamento, com indicação**
Ferramenta para obesidade e melhora metabólica, não solução estética.

04 **O cardiologista avalia o risco no caminho**
Tratar o peso e cuidar do coração acontecem juntos.

05 **Particular e convênios**
Atendimento em Santo André, conforme a operadora e o plano.

A ESTRATÉGIA

# Autoridade sem distribuição não gera consulta. Distribuição sem autoridade não gera confiança.

O podcast resolve as duas pontas de uma vez: o Dr. Cesar mostra o que sabe com profundidade, e cada bloco vira conteúdo curto que chega a quem precisa marcar a consulta.

AUTORIDADE

### Trajetória que dá confiança

Cerca de 18 anos de medicina, passagens por HCor, Rede D'Or, Hospital Brasil e Beneficência Portuguesa, SUS e formação de residentes.

EDUCAÇÃO

### Prevenção em linguagem simples

Obesidade, hábitos, atletas, sinais de alerta e mitos: o que o paciente pesquisa, explicado por quem atende todo dia.

PROXIMIDADE

### Santo André e todo o ABC

Consultório próprio, atendimento particular e por convênios. O ouvinte termina o episódio sabendo como agendar.

**1 gravação**
episódio completo de cerca de 60 minutos

**13 cortes**
prioritários para Reels e Shorts

**16 pílulas**
mito ou verdade e perguntas do público

**4 semanas**
de conteúdo saindo de um único dia de gravação

A ESCALETA

# A ordem do episódio: gancho forte primeiro, autoridade logo depois.

| # | BLOCO | OBJETIVO | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 00 | **Abertura: cold open e apresentação** | Autoridade | 2 min |
| 01 | **Obesidade, 50+ e Mounjaro** | Gancho forte e identificação | 7 min |
| 02 | **História e trajetória do Dr. Cesar** | Autoridade e conexão | 6 min |
| 03 | **Mais de 400 mil mortes por ano** | Conscientização | 5 min |
| 04 | **Prevenção x expectativa de vida · 50+** | Valorizar o acompanhamento | 6 min |
| 05 | **Atletas e doenças silenciosas** | Ampliar público | 5 min |
| 06 | **Cinco inimigos e cinco hábitos** | Educação | 6 min |
| ⚡ | **Bate-bola: mito ou verdade** NOVO | Ritmo e cortes curtos | 4 min |
| 07 | **Segunda opinião** | Proximidade regional | 4 min |
| 08 | **Mounjaro e saúde cardiovascular** | Aprofundamento científico | 7 min |
| ! | **Sinais que não esperam a consulta** NOVO | Utilidade pública | 3 min |
| 09 | **Acompanhamento, ABC e convênios** | Conversão | 4 min |
| 10 | **Convite final** | Agendamento | 3 min |
| + | **Pílulas do público, gravadas depois** NOVO | Série de shorts | 10 min |

RECOMENDAÇÃO

## A tirzepatida aparece duas vezes, de propósito.

Abre o episódio como gancho, no bloco 01, e volta no bloco 08 para aprofundar benefícios, limites e cuidados.

Assim o Dr. Cesar é o cardiologista que enxerga a obesidade como parte da saúde do coração e da longevidade, e não alguém que fala de emagrecimento.

Total: cerca de 62 min de conversa + 10 min de pílulas. Clique numa linha para ir ao bloco.

DIREÇÃO DE GRAVAÇÃO

# Como gravar para o episódio render cortes

Tom médico, mas acessível. Seguro, sem ser técnico demais. Próximo e humanizado, com autoridade e sem cara de apresentação comercial. **A ênfase é prevenção e longevidade.**

### Retome o tema na resposta

Comece repetindo o assunto: "A obesidade não é só estética...". Assim o corte faz sentido sozinho, sem a pergunta.

### Uma ideia por resposta

De 60 a 90 segundos por resposta. Se o assunto render, o host puxa uma das perguntas extras.

### Pausa na frase ★

Respire um segundo antes e depois das frases marcadas com ★. É ali que a edição corta.

### Fale com uma pessoa

Imagine o paciente de 55 anos com pressão alta. Troque sigla e termo técnico por infarto, AVC e pressão.

### Remédio pelo princípio ativo

"Tirzepatida, conhecida como Mounjaro." Sem dose, sem promessa e sem tom de propaganda.

### Sem promessa de resultado

Prefira "pode ajudar", "os estudos mostram" e "depende da avaliação". Paciente citado nunca é identificado.

### Olhe para o host

É conversa, não palestra. A exceção é o convite final: ali o Dr. Cesar olha direto para a câmera.

### Pense no vertical

Câmera fechada no Dr. Cesar com área segura para 9:16. A maior parte dos cortes vai para Reels e Shorts.

00 ABERTURA AUTORIDADE · 2 MIN

# Cold open, vinheta e a apresentação do Dr. Cesar.

**COLD OPEN · 10 A 15 S · NOVO**

Antes da vinheta, abra com a frase mais forte do bloco 01, já editada: **“Não espere emagrecer para descobrir como está seu coração.”** Depois entram a vinheta e a apresentação.

**DICA DE GRAVAÇÃO**

Grave a apresentação duas vezes: a completa e uma versão de 20 segundos, para usar como abertura dos cortes de trajetória.

**HOST · APRESENTAÇÃO**

“Hoje recebemos o Dr. Cesar, médico com aproximadamente 18 anos de trajetória profissional, sendo 16 anos de atuação na cardiologia.

Ao longo de sua carreira, passou por instituições importantes, como HCor, Rede D’Or, Hospital Brasil e Beneficência Portuguesa, além de sua atuação na rede de hospitais da região do ABC e no SUS, junto aos residentes da Faculdade de Medicina do ABC.

Atualmente, atende pacientes em Santo André e em toda a região, com uma proposta de cuidado que une prevenção, acompanhamento cardiovascular e qualidade de vida.

**Dr. Cesar, seja muito bem-vindo!**”

01 OBESIDADE, LONGEVIDADE E CORAÇÃO GANCHO · 7 MIN

# Emagrecer é estética ou é saúde do coração?

**HOST · PERGUNTA**

“Dr. Cesar, quero começar falando de um assunto que está muito presente na vida dos brasileiros: a obesidade.

Hoje, muita gente ainda enxerga o emagrecimento apenas como uma questão estética. Principalmente com a popularização das canetas emagrecedoras, como a Mounjaro, parece que o objetivo de muita gente é simplesmente perder peso e melhorar a aparência.

Mas existe uma questão muito mais importante: o que acontece com o coração de uma pessoa que convive com a obesidade durante anos? Uma pessoa obesa, especialmente depois dos 50 anos, com pressão alta, colesterol elevado, diabetes ou histórico familiar de problemas cardíacos, deveria estar fazendo uma avaliação cardiológica com urgência?

E quero entrar também em outro ponto: a Mounjaro e os medicamentos modernos para tratar a obesidade vão muito além da estética? Como o emagrecimento pode transformar a saúde metabólica e cardiovascular de um paciente?”

**POR QUE ABRIR COM ESTE TEMA**

É o assunto que o público já está pesquisando. **A conversa entra pela caneta e sai pela saúde do coração**, e isso segura quem chegou pelo tema do emagrecimento.

**PERGUNTAS EXTRAS · SE DER TEMPO** NOVO

- A barriga importa mais do que o número da balança?
- Ronco e apneia do sono têm a ver com o coração?
- Quem já emagreceu com a caneta ainda precisa passar pelo cardiologista?
- O que o senhor mais vê no consultório quando a pessoa chega só querendo emagrecer?

01 DIRECIONAMENTO · DR. CESAR

# A resposta em cinco tempos

**01**

### Mudar o olhar

Obesidade não é aparência nem só "estar acima do peso". É uma condição que compromete vários sistemas, principalmente o cardiovascular.

**02**

### O que acontece com o coração

Mais sobrecarga e mais fatores de risco: hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alterado e apneia do sono.

**03**

### O alerta do 50+

Acima dos 50 e com comorbidades, a avaliação não pode ser adiada, mesmo sem nenhum sintoma.

**04**

### Olhar integral

Cerca de 18 anos de medicina, 16 na cardiologia: olhar o paciente como um todo, não só o peso.

**05**

### Tirzepatida com critério

Pode melhorar glicemia, pressão e indicadores metabólicos. Não é milagre estético nem substitui o cardiologista. Indicação individualizada.

**ATENÇÃO NA FALA**

Ao citar a caneta, diga "tirzepatida, o princípio ativo da Mounjaro" e reforce que a indicação é médica, com avaliação de riscos, benefícios e contraindicações.

★ FRASE DE CORTE — **"Não espere emagrecer para descobrir como está seu coração. Cuide do coração enquanto trata a obesidade."**

01 PERGUNTA COMPLEMENTAR E CONVERSÃO

# Quem procura ajuda para emagrecer deveria aproveitar para olhar o coração?

**HOST · COMPLEMENTAR**

"Então podemos dizer que uma pessoa que está procurando ajuda para emagrecer também deveria aproveitar esse momento para investigar a saúde do coração?

E, na sua opinião, por que alguém com obesidade e mais de 50 anos não deveria continuar adiando essa avaliação?"

**CTA PRINCIPAL DO EPISÓDIO**

"Se você tem mais de 50 anos, está acima do peso, tem pressão alta, diabetes ou colesterol elevado, não espere sentir alguma coisa para procurar ajuda. Agende sua avaliação cardiológica. Atendemos também por convênios."

**DR. CESAR · FECHAMENTO**

- **"Exatamente."** É a oportunidade de olhar a saúde como um todo.
- A pessoa chega preocupada com o peso, e o médico olha **pressão, colesterol, glicemia, função cardíaca** e os demais fatores de risco.
- Não precisa esperar uma dor no peito ou um infarto para começar a investigar.
- Convite direto: tem mais de 50 anos, obesidade ou outras condições? **Coloque a avaliação cardiológica como prioridade na agenda.**
- Atendimento também por convênios, conforme a operadora e o plano.

★ FRASE DE CORTE — **"Emagrecer pode mudar sua aparência. Cuidar da saúde cardiovascular pode mudar a sua história de vida."**

02 HISTÓRIA E TRAJETÓRIA · AUTORIDADE E CONEXÃO · 6 MIN

# Quem é o Dr. Cesar, e por que Santo André?

HCor · Rede D'Or · Hospital Brasil · Beneficência Portuguesa · Rede América · ABC · SUS · Faculdade de Medicina do ABC · Consultório em Santo André

**HOST · PERGUNTA**

"Dr. Cesar, na abertura eu contei um pouco da sua trajetória: são cerca de 18 anos de medicina, passando por instituições como HCor, Rede D'Or, Hospital Brasil e Beneficência Portuguesa, pela Rede América, no ABC, e pelo SUS, junto aos residentes da Faculdade de Medicina do ABC.

Mas eu quero ouvir de você: como foi construir esse caminho? O que despertou a vontade de seguir a cardiologia, e o que fez você decidir abrir o seu próprio consultório em Santo André?"

**TRANSIÇÃO PARA O BLOCO 03**

"E quando olhamos para toda essa experiência, uma coisa chama atenção: muita gente só procura o cardiologista quando já existe algum problema. Será que estamos cuidando do coração da maneira correta?"

**DR. CESAR · DIRECIONAMENTO**

- Como surgiu a escolha pela medicina e pela cardiologia.
- A experiência nos hospitais e instituições por onde passou.
- Um momento marcante da carreira.
- O que aprendeu atendendo perfis tão diferentes de pacientes.
- A decisão de construir o próprio espaço de atendimento.
- O propósito: atendimento **próximo, humanizado e individualizado**.
- O que mais motiva hoje e o legado que quer deixar.

**PERGUNTAS EXTRAS · SE DER TEMPO** NOVO

+ Qual paciente mudou o seu jeito de ser médico? (sem identificar a pessoa)
+ O que formar residentes no SUS te ensinou sobre explicar a doença ao paciente?
+ No hospital grande tudo é rápido. O que você quis fazer diferente no consultório?

03 O TAMANHO DO PROBLEMA · DADO VALIDADO · SBC

# Mais de 400 mil mortes por ano. E quase ninguém conhece o Setembro Vermelho.

NO BRASIL, EM 2026

## 1 a cada 72s

**uma pessoa morre por doença cardiovascular. Em média, 1.194 mortes por dia.**

Cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, acumulado até 16/10/2026.

OUTUBRO ROSA

**Câncer de mama**

Todo mundo conhece.

NOVEMBRO AZUL

**Saúde do homem**

Todo mundo conhece. E é o mês do episódio.

SETEMBRO VERMELHO

**Coração**

Quase ninguém sabe responder.

**417.550**

mortes por doenças cardiovasculares em 2024, último ano fechado

**318.945**

mortes em 2026, de 1º de janeiro a 16 de outubro

GANCHO DO MÊS

O episódio sai em pleno Novembro Azul. Vale o host lembrar: **cuidar do coração também é saúde do homem**, e da mulher, o ano inteiro.

Fonte: SBC, Cardiômetro e Hub de Doenças Cardiovasculares (Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde e estimativas GBD 2023). Consulta em 06/11/2026; o contador muda todo dia.

03 A PREVENÇÃO QUE POUCA GENTE CONHECE CONSCIENTIZAÇÃO · 5 MIN

# Por que falamos tão pouco de prevenção do coração?

**HOST · PERGUNTA**

"Dr. Cesar, existe algo que me parece muito preocupante: segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares mataram mais de 400 mil brasileiros em 2024. É uma morte a cada 72 segundos.

Mesmo assim, a prevenção do coração parece não ter o mesmo espaço na nossa agenda de saúde. Todo mundo conhece o Outubro Rosa e o Novembro Azul, mas pergunte para qualquer pessoa o que é o Setembro Vermelho, campanha de conscientização sobre doenças cardiovasculares, e provavelmente pouca gente vai saber responder.

Por que ainda falamos tão pouco sobre prevenção cardíaca? E o que as pessoas deveriam fazer, antes de ter um infarto, para descobrir se estão realmente cuidando bem do coração?"

**DR. CESAR · DIRECIONAMENTO**

- Doenças cardiovasculares como **problema de saúde pública**.
- A cultura de só procurar atendimento quando aparecem sintomas.
- Hipertensão, colesterol elevado e diabetes podem **evoluir em silêncio**.
- Dá para se sentir saudável e ainda ter fatores de risco.
- O que a avaliação olha: histórico familiar, hábitos, pressão arterial e exames laboratoriais.
- Exames complementares são pedidos **conforme a necessidade de cada pessoa**.

**PERGUNTA EXTRA** NOVO

+ Se a pessoa nunca foi ao cardiologista, o que acontece na primeira consulta?

**MENSAGEM-CHAVE**

**"Não precisamos esperar o coração dar um sinal de alerta para começar a cuidar dele. Prevenir não é procurar uma doença. É ter a oportunidade de identificar riscos e agir antes."**

04 LONGEVIDADE · PARTE 1 VALORIZAR O ACOMPANHAMENTO · 3 MIN

# Não é só viver mais. É viver melhor.

**HOST · PERGUNTA**

"Dr. Cesar, queria trazer uma questão para quem está nos ouvindo.

Na prática, qual é a diferença na qualidade e na expectativa de vida de uma pessoa que faz acompanhamento cardiológico preventivo e de alguém que só procura um médico quando sente algum sintoma?

Estamos falando apenas de evitar um infarto, ou essa prevenção também pode significar viver mais anos, com mais disposição, autonomia e qualidade de vida?"

**PERGUNTA EXTRA** NOVO

- O que é envelhecer bem para o senhor? Tem um exemplo de paciente que voltou a fazer o que gostava? (sem identificar)

**DR. CESAR · DIRECIONAMENTO**

- A importância de identificar fatores de risco **cedo**.
- Controle da pressão arterial, do colesterol e da glicemia.
- Como o acompanhamento ajuda a orientar e sustentar mudanças de hábito.
- O objetivo não é só evitar eventos cardiovasculares: é **preservar a autonomia**.
- Envelhecer com disposição para trabalhar, viajar, se exercitar e aproveitar a família.
- Cada paciente precisa de uma **estratégia individualizada**.

★ MENSAGEM-CHAVE

**"Não queremos apenas que as pessoas vivam mais. Queremos que vivam melhor, com independência, disposição e saúde para aproveitar a família, o trabalho e tudo aquilo que conquistaram."**

04 O PÚBLICO 50+ · PARTE 2 3 MIN

# A partir dos 50, prevenção precisa entrar na agenda.

**HOST · PERGUNTA**

"Dr. Cesar, quero falar especialmente com quem está na faixa dos 50 anos ou já passou dela.

Muitas pessoas chegam a essa idade trabalhando, cuidando da família, realizando projetos e mantendo uma rotina aparentemente normal. Mas acabam deixando a própria saúde em segundo plano.

Você acredita que, a partir dos 50 anos, o acompanhamento cardiovascular deveria ganhar ainda mais espaço na rotina das pessoas? O que muda nessa fase da vida, e por que é tão importante conhecer os próprios fatores de risco antes que aconteça alguma complicação?"

**PERGUNTA EXTRA** NOVO

+ Um recado para os filhos: como puxar esse assunto com o pai e a mãe sem virar briga?

**DR. CESAR · DIRECIONAMENTO**

- Com o passar dos anos, acompanhar os fatores de risco fica ainda mais importante.
- O peso de **hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, histórico familiar e sedentarismo**.
- A idade sozinha não define o risco: o histórico individual também conta.
- Quem cuidou da carreira e da família, mas deixou a própria saúde para depois.
- Filhos e familiares podem e devem puxar essa conversa.
- A avaliação é sempre individualizada.

★ FALA DE IMPACTO

**"Eu gostaria muito que as pessoas da minha geração chegassem ao consultório para fazer prevenção, e não apenas depois de um infarto, de um AVC ou de uma complicação que poderia ter sido identificada antes."**

05 ATLETAS E PESSOAS ATIVAS · AMPLIAR PÚBLICO · 5 MIN

# Quem treina está automaticamente protegido?

**HOST · PERGUNTA**

"Dr. Cesar, hoje vemos cada vez mais pessoas praticando musculação, corrida, ciclismo e até esportes de alta performance.

Muitas delas treinam diariamente, têm uma alimentação controlada e acreditam que, por terem um excelente condicionamento físico, estão automaticamente protegidas contra problemas cardíacos. Mas será que isso é verdade?

Um atleta, mesmo em excelente forma física, pode ter uma doença cardíaca silenciosa? Quais cuidados e avaliações são importantes para quem exige muito do próprio coração durante os treinos?"

**DR. CESAR · DIRECIONAMENTO**

- Condicionamento físico **não elimina todos os riscos** cardiovasculares.
- Histórico familiar e possíveis doenças silenciosas.
- Avaliar sintomas, histórico e a intensidade da atividade.
- Eletrocardiograma e outros exames **quando houver indicação**.
- A avaliação considera idade, modalidade, intensidade e perfil de quem pratica.
- Exercício é excelente, mas não substitui o acompanhamento médico.

**PERGUNTAS EXTRAS · SE DER TEMPO** NOVO

- Começou a treinar depois dos 40: precisa de avaliação antes?
- Anabolizantes e pré-treinos muito fortes: qual o risco para o coração?
- Que sintoma no treino é sinal para parar e procurar o médico?

**MENSAGEM-CHAVE** "Treinar é cuidar da saúde, mas conhecer os limites e as condições do próprio coração também faz parte de uma vida saudável."

06 OS CINCO INIMIGOS E OS CINCO HÁBITOS · EDUCAÇÃO · 6 MIN · VIRA CARROSSEL DUPLO

# O que estamos fazendo de errado na rotina?

**HOST · PERGUNTA**

"Dr. Cesar, sabemos que muitas doenças cardiovasculares estão relacionadas aos nossos hábitos de vida. Se você pudesse listar os cinco principais hábitos que prejudicam o coração, quais seriam? E, na contramão, quais são os cinco hábitos que todos deveriam adotar para proteger o coração e viver mais e melhor?"

## OS CINCO INIMIGOS DO CORAÇÃO — EVITAR

1. **Sedentarismo**
   Passar o dia sentado e não praticar atividade física regularmente.
2. **Má alimentação**
   Excesso de sal, açúcar, ultraprocessados e gordura saturada.
3. **Tabagismo**
   O cigarro agride os vasos e aumenta o risco de infarto e AVC.
4. **Sono ruim e estresse crônico**
   Negligenciar o descanso e viver sob pressão o tempo todo.
5. **Falta de acompanhamento**
   Não controlar pressão, colesterol e glicemia e esperar o sintoma.

## CINCO ATITUDES PARA PROTEGER — ADOTAR

1. **Atividade física regular**
   Aeróbico e musculação, conforme a condição de cada um.
2. **Alimentação equilibrada**
   Fibras, frutas, verduras e alimentos naturais.
3. **Dormir bem**
   De 7 a 9 horas de sono por noite, quando possível.
4. **Peso e números sob controle**
   Peso adequado e pressão, colesterol e glicemia acompanhados.
5. **Acompanhamento preventivo**
   Considerando histórico familiar e fatores individuais de risco.

**MENSAGEM-CHAVE**

**"Não precisamos mudar tudo de uma vez. Pequenas mudanças consistentes fazem diferença ao longo dos anos. O importante é começar e manter o cuidado."**

⚡ BATE-BOLA · MITO OU VERDADE · NOVO · 4 MIN

# O host lê a frase. O Dr. Cesar responde em até 20 segundos.

Muda o ritmo depois do bloco mais educativo e gera uma série pronta de shorts. Dr. Cesar: responda começando por “Mito” ou “Verdade”, e depois explique em uma frase.

MITO

**“Quem não sente nada não precisa de cardiologista.”**

Pressão alta, colesterol e diabetes podem evoluir em silêncio por anos.

VERDADE

**“Pressão alta pode não dar nenhum sintoma.”**

Por isso ela é perigosa: só medindo para saber.

MITO

**“Colesterol alto é coisa de quem está acima do peso.”**

A genética pesa. Gente magra também pode ter colesterol alto.

VERDADE

**“O infarto na mulher pode dar sintomas diferentes.”**

Cansaço, falta de ar, náusea, dor nas costas ou na mandíbula, nem sempre a dor clássica no peito.

MITO

**“Quem treina todo dia está protegido.”**

Condicionamento não elimina doença silenciosa nem histórico familiar.

MITO

**“A caneta substitui dieta e exercício.”**

Ela é parte do tratamento. Alimentação, atividade física e acompanhamento continuam.

VERDADE

**“Ronco alto pode ter a ver com o coração.”**

A apneia do sono está associada a pressão alta e arritmias. Vale investigar.

MITO

**“Check-up do coração é igual para todo mundo.”**

Os exames dependem da idade, do histórico e dos fatores de risco de cada um.

07 SEGUNDA OPINIÃO · PROXIMIDADE REGIONAL · 4 MIN

# Saiu do consultório com dúvida? Quando procurar uma segunda opinião.

**HOST · PERGUNTA**

"Dr. Cesar, muitas pessoas recebem um diagnóstico, fazem exames ou começam um tratamento e acabam ficando com dúvidas. Às vezes, não sabem exatamente o que aquele resultado significa, por que determinado medicamento foi indicado ou quais são as alternativas de tratamento.

Quando é importante procurar uma segunda opinião cardiológica? E como esse acompanhamento pode ajudar o paciente a compreender melhor sua condição e tomar decisões mais seguras sobre a própria saúde?"

**DR. CESAR · DIRECIONAMENTO**

- Segunda opinião é uma **atitude legítima** e pode trazer mais clareza.
- Revisão de exames, diagnósticos e tratamentos.
- O objetivo não é desautorizar outro profissional, e sim **ampliar a compreensão do caso**.
- Levar exames anteriores e o histórico clínico faz diferença.
- O paciente precisa entender a própria condição e participar das decisões.
- **Nunca interromper um tratamento por conta própria.**

**O QUE LEVAR NA CONSULTA · VIRA CARROSSEL** NOVO

- Exames e laudos anteriores, mesmo os antigos
- Lista dos remédios em uso, com a dose
- Medidas de pressão anotadas em casa
- Histórico da família: quem teve infarto ou AVC, e com que idade
- As dúvidas escritas num papel

**MENSAGEM-CHAVE** **"Entender o próprio diagnóstico e o tratamento é parte fundamental do cuidado. Se você tem dúvidas, buscar uma segunda opinião especializada pode ajudar a decidir com mais segurança."**

08 MOUNJARO E SAÚDE CARDIOVASCULAR APROFUNDAMENTO CIENTÍFICO · 7 MIN

# A caneta para emagrecer também pode ajudar o coração?

**HOST · PERGUNTA**

"Dr. Cesar, lá no começo a gente falou da obesidade. Agora quero aprofundar. A Mounjaro, conhecida pelo efeito no emagrecimento e no controle da glicose, está muito em evidência.

Mas existe algo que muita gente ainda não sabe: além de ajudar na perda de peso, a tirzepatida também pode trazer benefícios para a saúde cardiovascular? Ela pode melhorar fatores de risco, como pressão arterial e alguns indicadores metabólicos?

E existe diferença entre usar esse medicamento só para emagrecer e usá-lo dentro de um tratamento acompanhado por médicos, pensando na saúde como um todo?"

**PERGUNTAS EXTRAS · SE DER TEMPO** NOVO

- Quais efeitos colaterais os pacientes mais relatam?
- Quando para a caneta, o peso volta?
- E a perda de massa muscular, como evitar?

**DR. CESAR · DIRECIONAMENTO**

- O que é a tirzepatida e **como ela atua**.
- Controle glicêmico e perda de peso.
- Possíveis melhorias em fatores metabólicos, como pressão arterial e alguns indicadores de colesterol.
- Como reduzir o excesso de peso ajuda a melhorar o risco cardiovascular.
- **Diferenciar melhora de fator de risco de prevenção comprovada de infarto ou AVC.**
- Não é um medicamento para uso indiscriminado.
- Avaliação individualizada e acompanhamento médico.
- A medicação não substitui os tratamentos cardiológicos indicados.

**MENSAGEM-CHAVE** **"Tratar a obesidade também é cuidar da saúde cardiovascular. Mas o tratamento precisa de indicação e acompanhamento médico, considerando a saúde do paciente como um todo."**

08 BASE CIENTÍFICA · PARA CONSULTA DO DR. CESAR NÃO É PARA LER NO AR

# O que os estudos mostram, e o que ainda não dá para afirmar.

| ESTUDO | QUEM PARTICIPOU | O QUE MOSTROU | COMO DIZER NO PODCAST |
|---|---|---|---|
| **SURMOUNT-1** NEJM · 2022 | 2.539 adultos com obesidade, sem diabetes | Perda média de 15% a 21% do peso em 72 semanas, conforme a dose (placebo: 3%) | *"Nos estudos, a perda de peso foi expressiva, mas varia de pessoa para pessoa."* |
| **SUMMIT** NEJM · 2024 | 731 pessoas com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e obesidade | Morte cardiovascular ou piora da insuficiência cardíaca: 9,9% contra 15,3% (−38%), puxado pela piora da doença; sintomas melhoraram | *"Em quem tem insuficiência cardíaca e obesidade, reduziu a piora da doença e melhorou a qualidade de vida."* |
| **SURPASS-CVOT** NEJM · 2025 | 13.299 pessoas com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular | Contra a dulaglutida, que já tinha benefício cardíaco comprovado: infarto, AVC ou morte cardiovascular em 12,2% contra 13,1% (não inferior); mortalidade geral 16% menor | *"Em quem tem diabetes e doença do coração, protegeu tanto quanto um remédio que já tinha esse benefício comprovado."* |
| **SURMOUNT-MMO** em andamento | Adultos com obesidade, sem diabetes, contra placebo | Vai responder se reduz infarto, AVC e morte nesse público. Resultado previsto para 2027 | *"Para quem tem só obesidade, ainda não dá para dizer que previne infarto. O estudo que responde isso está em andamento."* |

**NO BRASIL**

A Anvisa aprovou a tirzepatida para obesidade em junho de 2025: IMC a partir de 30, ou a partir de 27 com comorbidade. **Venda só com retenção de receita.**

**CUIDADOS PARA CITAR**

Efeitos gastrointestinais são os mais comuns. Perda de massa magra pede proteína e musculação. Ao parar, parte do peso tende a voltar.

**EVITE NO AR**

"Protege o coração de todo mundo." "Emagrece sem esforço." Doses, comparação de marcas e qualquer sugestão de uso sem receita.

Fontes: Jastreboff et al., NEJM 2022 · Packer et al., NEJM 2024 · Nicholls et al., NEJM 2025 · ClinicalTrials.gov NCT05556512 · Anvisa, DOU de 09/06/2025. Consulta em 06/11/2026. Validar com o Dr. Cesar antes de gravar.

— ! SINAIS QUE NÃO ESPERAM A CONSULTA NOVO · 3 MIN

# Prevenção vai para a agenda. Estes sinais vão para o pronto-socorro.

**HOST · PERGUNTA**

“Doutor, a gente falou muito de prevenção e de consulta marcada. Mas quais sinais não podem esperar a consulta de jeito nenhum?”

### Dor ou aperto no peito

Que dura mais de alguns minutos ou vai e volta, e pode irradiar para braço, costas, pescoço ou mandíbula.

### Falta de ar repentina

Principalmente se vier com suor frio, náusea ou mal-estar.

### Desmaio ou coração disparado

Palpitação forte com tontura, desmaio ou sensação de que vai desmaiar.

### Sinais de AVC: lembre do SAMU

**S**orria (a boca entorta?), **A**brace (um braço fraco?), **M**úsica (fala enrolada?), **U**rgente: ligue 192.

NA DÚVIDA

## 192

### Ligue para o SAMU. Não vá dirigindo.

Em mulheres, idosos e diabéticos, o infarto pode vir sem a dor clássica: cansaço, náusea, dor nas costas.

**POR QUE ESTE BLOCO NÃO TEM CTA**

É utilidade pública: aqui não se fala de agendamento. Confiança primeiro; a conversão vem no bloco 09.

09 ATENDIMENTO EM SANTO ANDRÉ E NO ABC · CONVERSÃO · 4 MIN

# Como funciona o acompanhamento no consultório?

**HOST · PERGUNTA**

"Dr. Cesar, temos muitas pessoas acompanhando nosso podcast aqui de Santo André e de toda a região do ABC Paulista.

Para quem mora na região e ainda não tem o hábito de fazer acompanhamento cardiológico, ou para quem já passou por uma avaliação, mas gostaria de uma segunda opinião especializada, como funciona o atendimento com você?

Quais pacientes podem se beneficiar desse acompanhamento? Estamos falando só de quem já tem algum problema cardíaco, ou também de quem quer fazer uma avaliação preventiva? E para quem tem convênio, existe essa possibilidade no seu consultório?"

**DR. CESAR · DIRECIONAMENTO**

- Apresentar o consultório e a localização em Santo André.
- Pacientes de Santo André, São Bernardo, São Caetano e demais cidades do ABC.
- Como funciona a consulta e a **avaliação individualizada**.
- Convênios: quais operadoras são aceitas e em que condições. Como agendar.

**MOTIVOS PARA PROCURAR**

Avaliação preventiva · Hipertensão · Colesterol e diabetes · Sintomas e fatores de risco · Quem treina · Doença já diagnosticada · Segunda opinião

**PARA PREENCHER ANTES DE GRAVAR**

- Endereço: [preencher]
- Convênios aceitos: [confirmar operadoras e planos]
- Agendamento: [WhatsApp · telefone · link]

**MENSAGEM-CHAVE**

**"Quero que as pessoas de Santo André e de todo o ABC saibam que podem procurar um cardiologista não apenas quando estão doentes, mas também quando querem preservar a saúde e cuidar do futuro."**

10 CONVITE FINAL · OLHAR PARA A CÂMERA AGENDAMENTO · 3 MIN

# “Não espere sentir alguma coisa para cuidar do seu coração.”

**HOST · PERGUNTA**

“Dr. Cesar, para encerrarmos, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem chegou até aqui.

Talvez seja uma pessoa que já passou dos 50 anos, tem pressão alta, colesterol elevado, diabetes ou histórico familiar de doenças cardíacas. Talvez seja alguém que trabalha muito, cuida de todo mundo e sempre deixa a própria saúde para depois. Ou alguém que está se sentindo bem e acredita que não precisa de um cardiologista porque não tem nenhum sintoma.

Qual seria o seu conselho para essas pessoas? Por que elas deveriam começar a cuidar do coração agora?”

**DR. CESAR · DIRECIONAMENTO**

- **Ausência de sintomas não é ausência de fatores de risco.**
- Incentivar a avaliação preventiva.
- Falar direto com quem tem mais de 50 anos e com quem tem comorbidades.
- Cuidar da saúde também é cuidar da família e da própria qualidade de vida.
- Convidar para uma consulta no consultório em Santo André.
- Mencionar o atendimento por convênios, conforme as operadoras.
- A prevenção começa com **uma conversa e uma avaliação individualizada**.

★ ÚLTIMA FRASE — **“Cuide do seu coração hoje. Ele ainda tem muita história para acompanhar.”**

+ PÍLULAS DO PÚBLICO NOVO · GRAVAR DEPOIS DO EPISÓDIO

# Oito perguntas que o paciente faz no consultório, respondidas em 40 segundos.

Gravadas em sequência, com o Dr. Cesar olhando para a câmera e enquadramento vertical. Cada uma vira um short. Depois, a caixinha de perguntas dos Stories alimenta a próxima rodada.

PÍLULA 01

### Com que idade devo ir ao cardiologista pela primeira vez?

Não existe idade única: depende do histórico e dos fatores de risco. Com 50+, a avaliação não deve ficar para depois.

PÍLULA 02

### Meu pai infartou aos 50. Eu tenho mais risco?

Infarto precoce na família (homem antes dos 55, mulher antes dos 65) aumenta o risco e antecipa a avaliação.

PÍLULA 03

### Eletro normal quer dizer coração saudável?

Ajuda muito, mas é um retrato do momento. A avaliação completa olha histórico, fatores de risco e, se preciso, outros exames.

PÍLULA 04

### Café faz mal para o coração?

Para a maioria, em quantidade moderada, não. Quem tem arritmia ou pressão descontrolada deve conversar com o médico.

PÍLULA 05

### Tenho pressão alta. Posso fazer musculação?

Na maioria dos casos, sim: exercício faz parte do tratamento, com a pressão controlada e orientação.

PÍLULA 06

### Estresse pode causar infarto?

O estresse crônico piora pressão, sono e hábitos, e pode ser o gatilho em quem já tem risco.

PÍLULA 07

### Sou magro. Posso ter colesterol alto?

Pode. A genética pesa muito. Peso não é exame: só o exame de sangue mostra.

PÍLULA 08

### A pressão normalizou. Posso parar o remédio?

Não por conta própria. Muitas vezes ela normalizou justamente porque o remédio está funcionando.

★ FRASES DE IMPACTO

BORDA LARANJA: FRASE NOVA

# Frases para cortes, chamadas e capas

"O melhor momento para cuidar do coração é antes de ele pedir socorro."

ABERTURA · TÍTULO

"Não espere emagrecer para descobrir como está seu coração."

BLOCO 01 · COLD OPEN

"Emagrecer pode mudar sua aparência. Cuidar do coração pode mudar a sua história."

BLOCO 01

"A ausência de sintomas não significa ausência de riscos."

BLOCO 03

"Prevenir não é procurar uma doença. É ter a oportunidade de agir antes."

BLOCO 03

"Não queremos apenas que você viva mais. Queremos que você viva melhor."

BLOCO 04

"A partir dos 50 anos, prevenção precisa entrar na agenda."

BLOCO 04

"Treinar é importante, mas conhecer a saúde do próprio coração também é."

BLOCO 05

"Pressão alta não dói. É por isso que ela é perigosa."

BATE-BOLA · NOVA

"Tratar a obesidade também é cuidar do coração."

BLOCO 08 · NOVA

"Peso não é exame."

PÍLULA 07 · NOVA

"Remédio que está funcionando não é remédio para parar por conta própria."

PÍLULA 08 · NOVA

"Cuidar da sua saúde também é cuidar da sua família."

BLOCO 10

"Não espere um susto para começar a se cuidar."

BLOCO 10

"Sua saúde não pode ficar para depois."

BLOCO 10

"Cuide do seu coração hoje. Ele ainda tem muita história para acompanhar."

BLOCO 10 · ENCERRAMENTO

PLANO DE CORTES

# 13 cortes prioritários, com o gancho dos 3 primeiros segundos

| # | CORTE | GANCHO NA TELA (3 S) | ORIGEM | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | **Obesidade não é só estética** | *"Você está tratando a obesidade só pelo espelho?"* | Bloco 01 | Reels · Shorts |
| 02 | **400 mil mortes e o Setembro Vermelho** | *"Você conhece o Outubro Rosa. E o Setembro Vermelho?"* | Bloco 03 | Reels · carrossel |
| 03 | **Passou dos 50?** | *"Passou dos 50? Isso precisa entrar na sua agenda."* | Bloco 04 | Reels · Shorts |
| 04 | **Atleta também tem doença silenciosa** | *"Treina todo dia? Seu coração ainda pode esconder algo."* | Bloco 05 | Reels · Shorts |
| 05 | **Os cinco inimigos do coração** | *"Cinco hábitos que estão cansando o seu coração."* | Bloco 06 | Reels · carrossel |
| 06 | **Os cinco hábitos que protegem** | *"Cinco atitudes para viver mais e melhor."* | Bloco 06 | Reels · carrossel |
| 07 | **Tirzepatida e o coração** | *"A caneta emagrecedora também cuida do coração?"* | Bloco 08 | Reels · YouTube |
| 08 | **Segunda opinião** | *"Saiu da consulta com dúvida? Isso é para você."* | Bloco 07 | Reels |
| 09 | **Viver mais x viver melhor** | *"Não é só viver mais. É viver melhor."* | Bloco 04 | Reels · Shorts |
| 10 | **A trajetória do Dr. Cesar** | *"18 anos de medicina em um minuto."* | Bloco 02 | Reels · Google |
| 11 | **Sinais que não esperam** | *"Sentiu isso? Não marque consulta: ligue 192."* | Sinais de alerta | Reels · destaque |
| 12 | **Convite para Santo André e o ABC** | *"Mora no ABC? Este recado é para você."* | Bloco 10 | Reels · anúncio |
| 13 | **Séries "Mito ou verdade" e "Pílulas"** | 16 shorts curtos, publicados em sequência | Bate-bola · pílulas | Shorts · Stories |

DEPOIS DA GRAVAÇÃO

# Uma gravação, um mês de conteúdo, e cada conversa medida.

## SEMANA 1
### Lançamento

- Episódio completo no **YouTube e no Spotify**
- Trailer de 30 s com o cold open
- Cortes 01 (obesidade) e 10 (trajetória)
- Post no Perfil da Empresa no Google

## SEMANA 2
### Prevenção

- Cortes 02, 03 e 09
- Carrossel “400 mil mortes por ano”
- Stories com caixinha de perguntas
- Começa a série “Mito ou verdade”

## SEMANA 3
### Hábitos e esporte

- Cortes 04, 05, 06 e 11
- Carrossel duplo inimigos x hábitos
- Sinais de alerta fixado nos destaques
- Primeiras pílulas do público

## SEMANA 4
### Conversão

- Cortes 07, 08 e 12
- Carrossel “o que levar na consulta”
- Anúncio regional no ABC com o convite final
- Pílulas com as perguntas da caixinha

**COMO MEDIMOS**

Todo corte leva ao WhatsApp com a mensagem pronta **“Olá, vi o podcast do Dr. Cesar e quero agendar uma avaliação”**. Assim contamos quantas conversas o episódio gerou, no mesmo relatório mensal do Grupo Opera.

ANTES DE GRAVAR E DE PUBLICAR

# Checklist: validar antes, publicar com segurança.

## ANTES DE GRAVAR · COM O DR. CESAR

- [ ] Confirmar o tempo de carreira: cerca de 18 anos de medicina e 16 de cardiologia
- [ ] Confirmar os nomes oficiais das instituições
  HCor, Rede D'Or, Hospital Brasil, BP (Beneficência Portuguesa de São Paulo), FMABC, e se é "Rede América" ou "Rede Américas"
- [ ] Lista dos convênios aceitos: operadoras e planos
- [ ] Endereço, telefone, WhatsApp e link de agendamento
- [ ] CRM e RQE de cardiologia, para legendas e descrição
- [ ] Dr. Cesar revisou a base científica da tirzepatida

## ANTES DE PUBLICAR

- [x] Dado de mortalidade validado: 417.550 mortes em 2024 (SBC)
  Conferido em 06/11/2026
- [ ] Em toda peça: nome, CRM com a palavra "médico" e especialidade com RQE
  Resolução CFM nº 2.336/2023
- [ ] Sem promessa de resultado, e nenhum exame apresentado como obrigatório para todos
- [ ] Medicamento citado pelo princípio ativo, em tom educativo
  Remédio vendido com receita não pode ter propaganda dirigida ao público
- [ ] Aviso na descrição: "Conteúdo informativo. Não substitui a consulta médica."
- [ ] Nenhum paciente identificado nas histórias, e cortes aprovados pelo Dr. Cesar



AS MARCAÇÕES FICAM SALVAS NESTE NAVEGADOR

PRÓXIMOS PASSOS

# Pronto para gravar.

**PASSO 01**

### Validar com o Dr. Cesar

Checklist e base científica, numa conversa de 30 minutos antes da diária de gravação.

**PASSO 02**

### Gravar o episódio

Cerca de 60 minutos de conversa e mais 10 minutos de pílulas, já pensando no vertical.

**PASSO 03**

### Publicar e medir

Quatro semanas de cortes, com cada conversa no WhatsApp contada no relatório.

Grupo Opera.

ACELERADORA DE CRESCIMENTO